

参 考 文 献

1. Leblanc LA, Goldsmith T, Patel DR. Behavioral aspects of chronic illness in children and adolescents. *Pediatr Clin North Am.* 2003; 50(4) : 859 – 878.
2. Speechley KN, Barrera M, Shaw AK, et al. Health – related quality of life among child and adolescent survivors of childhood cancer. *J Clin Oncol.* 2006; 24(16) : 2536 – 2543.
3. Liang HF, Chiang YC, Chien LY, et al. A comparison of emotional/behavioural problems between Taiwanese children with cancer and healthy controls. *J Clin Nurs.* 2008; 17(3) : 304 – 311.
4. Theunissen JM, Hoogerbrugge PM, van Achterberg T, et al. Symptoms in the Palliative Phase of Children With Cancer. *Pediatr Blood Cancer* ,2007; 49(2) : 160 – 165.
5. Alessi D, Dama E, Barr R, et al. Health – related quality of life of longt – term childhood cancer survivors: apopulation – based study from the Childhood Cancer Registry of Piedmont, Italy. *Eur J Cancer*,2007; 43(17) : 2545 – 2552.
6. Pogany L, Barr RD, Shaw A, et al. Health status in survivors of cancer in childhood and adolescence, *Qual Life Res.* 2006; 15(1) : 143 – 157.
7. Recklitis CS, Lockwood RA, Rothwell MA, et al. Suicidal ideation and at tempts in adult survivors of childhood cancer. *J Clin Oncol.* 2006; 24(24) : 3852 – 3857.
8. Addington J, Penn D, Woods SW, et al. Social functioning in individuals at clinical high risk for psychosis. *Schizophr Res.* 2008; 99(1 – 3) : 119 – 124.
9. Yamazaki S, Sokejima S, Mizoue T, et al. Health – related quality of life of mothers of children with leukemia in Japan. *Qual Life Res.* 2005; 14(4) : 1079 – 1085.
10. Ruland CM, Hamilton GA, Schjødt – Osmo B. The complexity of symptoms and problems experienced in children with cancer: a review of the literature. *J Pain Symptom Manage*,2009; 37(3) : 403 – 418.
11. Eiser C, Eiser JR, Stride CB. Quality of life in children newly diagnosed with cancer and their mothers. *Health Qual Life Outcomes* , 2005; 28(3) : 385 – 391.
12. Sitaresmi MN, Mostert S, Purwanto I. Chemotherapy – related side effects in childhood acute lymphoblastic leukemia in Indonesia: parental perceptions. *J Pediatr Oncol Nurs.* 2009; 26(4) : 198 – 207.
13. Campbell LK, Scaduto M, Van Slyke D, et al. Executive function, coping, and behavior in survivors of childhood acute lymphocytic leukemia. *J Pediatr Psychol.* 2009; 34(3) : 317 – 327.
14. McSherry M, Kehoe K, Carroll JM, et al. Psychosocial and spiritual needs of children living with a life – limiting illness. *Pediatr Clin North Am.* 2007; 54(5) : 609 – 629.
15. Hurwitz CA, Duncan J, Wolfe J. Caring for the child with cancer at the close of life “there are people who make it, and I’m hoping I’m one of them”. *JAMA.* 2004; 292(17) : 2141 – 2149.

(收稿日期: 2010 年 6 月 27 日)

心境稳定剂的药物相互作用

刘 阳

【摘要】本文综述了丙戊酸钠和卡马西平与其他精神药物的相互作用。

【关键词】丙戊酸钠; 卡马西平; 相互作用; 血药浓度

【中图分类号】R749.05 【文献标识码】A 【文章编号】1673 – 2952 (2011) 04 – 0266 – 03

心境稳定剂除了碳酸锂以外, 主要由丙戊酸钠和卡马西平组成, 拉莫三嗪的应用虽然也呈上升趋势, 但仍不及丙戊酸钠和卡马西平的使用频度高,

这里将综述丙戊酸钠和卡马西平与其他精神药物相互作用。

一、丙戊酸钠增加精神药物血浓度

(作者工作单位) 南京医科大学附属脑科医院 (南京, 210029) 。

(第一作者简介) 刘阳 (1965—), 男, 副主任技师, 本科, 研究方向: 精神药理。

1. 丙戊酸钠增加氯氮平血浓度

氯氮平经细胞色素 3A4 酶 (次主要)、2C19 (次主要)、2C9 (次要) 酶代谢, 次主要经葡萄糖醛酸结合清除, 丙戊酸钠轻度抑制 3A4 酶, 抑制 2C19 和 2C9 酶, 广泛抑制葡萄糖醛酸结合, 故能增加氯氮平血浓度, 此时应控制氯氮平用量。

2. 丙戊酸钠增加三环抗抑郁药血浓度

(1) 增加阿米替林血浓度: 阿米替林和去甲替林主要经 2C19 酶和次要经 3A4 酶去甲基, 部分经葡萄糖醛酸结合清除; 丙戊酸钠抑制该二种酶, 并广泛抑制葡萄糖醛酸结合, 故能增加阿米替林和去甲替林血浓度 50% ~ 60%, 需监测阿米替林和去甲替林游离血浓度^[1]。

(2) 增加氯丙咪唑血浓度: 氯丙咪唑主要经 2C19 酶和次要经 3A4 酶去甲基, 丙戊酸钠抑制 2C19 酶, 轻度抑制 3A4 酶^[1], 故能增加氯丙咪唑中毒危险性, 表现抗胆碱能 (激越、意识模糊、幻觉、心动过速和尿潴留) 和抗组胺能 (癫痫发作和昏迷) 中毒体征^[1]。

3. 丙戊酸钠增加抗抽搐药血浓度

(1) 增加卡马西平血浓度: 卡马西平经 3A4 酶代谢, 经葡萄糖醛酸结合清除, 丙戊酸钠轻度抑制该酶并广泛抑制葡萄糖醛酸结合^[1], 故能增加卡马西平血浓度, 甚至引起卡马西平中毒, 表现共济失调、眼球震颤、复视、头痛、呕吐、癫痫发作和昏迷, 此时卡马西平应减量, 并测定其血药浓度。

(2) 增加拉莫三嗪血浓度: 拉莫三嗪经 3A4 酶代谢, 63% 的经葡萄糖醛酸结合清除。同理丙戊酸钠可抑制拉莫三嗪代谢, 增加拉莫三嗪血浓度 100%, 导致拉莫三嗪中毒, 表现疲劳、思睡和共济失调, 增加致命性皮疹危险性。故当丙戊酸钠联用拉莫三嗪时, 拉莫三嗪用量应折半^[1]。

(3) 增加苯巴比妥血浓度: 苯巴比妥经 2C19 酶代谢, 次主要经 2C9 酶代谢, 丙戊酸钠对二者的抑制可增加苯巴比妥血浓度。同时服丙戊酸钠可致苯巴比妥中毒, 此时应监测苯巴比妥中毒体征, 有条件的定期监测苯巴比妥血浓度^[1], 必要时降低苯巴比妥剂量。

(4) 增加苯妥英血浓度: 苯妥英主要经 2C9 酶代谢, 也经 2C19 酶代谢^[1]。丙戊酸钠抑制 2C9 和 2C19 酶, 故能增加苯妥英血浓度。

4. 增加苯二氮䓬类药物血浓度

(1) 可能增加地西泮血浓度: 丙戊酸钠的蛋白结合率高, 在血浆蛋白结合位点上可取代地西泮, 增加地西泮游离血浓度; 地西泮主要经 3A4 酶代谢, 丙戊酸盐弱抑制 3A4 酶^[1], 从而弱抑制地西泮代谢, 理论上轻度增加地西泮血浓度^[1]。

(2) 可能增加氯羟安定血浓度: 氯羟安定经葡萄糖醛酸结合清除^[1]。丙戊酸钠广泛抑制葡萄糖醛酸结合, 故能增加氯羟安定血浓度。此时应降低氯羟安定剂量 50%, 观察病人氯羟安定中毒体征, 如过度镇静和呼吸抑制^[1]。

二、其他药物影响丙戊酸钠血浓度

1. 其他药物增加丙戊酸钠血浓度

(1) 利培酮增加丙戊酸钠血浓度: 不典型抗精神病药总的无显著影响其他药物血浓度, 可是, 已有利培酮增加丙戊酸钠血浓度的报告。

(2) 安非他酮增加丙戊酸钠血浓度: 安非他酮重度抑制 2D6 酶, 丙戊酸钠未经 2D6 酶代谢, 理应不影响丙戊酸钠血浓度。可是, 研究提示, 安非他酮可增加丙戊酸钠血浓度^[1]。

(3) 非尔氨酯理论上增加丙戊酸钠血浓度: 40% 的丙戊酸钠经线粒体中的 β -氧化代谢, 非尔氨酯抑制 β -氧化代谢^[1], 理论上抑制丙戊酸钠的 β -氧化代谢, 增加丙戊酸钠血浓度, 临床上有待证实。

2. 其他药物降低丙戊酸钠血浓度

(1) 卡马西平降低丙戊酸钠血浓度: 丙戊酸钠次要 (<10%) 经 3A4 酶代谢, 卡马西平虽诱导 3A4 酶, 理论上降低丙戊酸钠不明显。但实际上, 同时服卡马西平能降低丙戊酸钠功效, 此时应监测丙戊酸钠血浓度^[1]。

(2) 拉莫三嗪降低丙戊酸钠血浓度: 拉莫三嗪弱诱导尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶^[1], 增加丙戊酸钠与葡萄糖醛酸结合, 增加丙戊酸钠清除 38%, 降低丙戊酸钠血浓度。

(3) 托吡酯很少降低丙戊酸钠血浓度: 40% 的丙戊酸钠经线粒体中的 β -氧化代谢, <10% 的经 3A4 酶代谢, 有报道托吡酯诱导 β -氧化途径, 诱导 3A4 酶, 理论上加速丙戊酸钠代谢, 降低其血药浓度, 但实际上, 托吡酯仅降低丙戊酸钠血浓度 11%。

(4) 苯巴比妥降低丙戊酸钠血浓度: 苯巴比妥诱导尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶^[1], 理论上增加丙戊酸钠与葡萄糖醛酸的结合, 降低丙戊酸钠

血浓度, 实际上, 苯巴比妥也的确降低丙戊酸钠效应^[1]。

(5) 噻加宾理论上降低丙戊酸钠血浓度: 噻加宾诱导尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶^[3], 增加丙戊酸钠与葡萄糖醛酸的结合, 理论上降低丙戊酸钠血浓度, 实际有待验证。

(6) 雌激素降低丙戊酸钠血浓度: 含雌激素的口服避孕药诱导尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶, 增加丙戊酸钠与葡萄糖醛酸的结合, 降低丙戊酸钠血浓度^[1]。有观点认为: 当丙戊酸钠与诱导葡萄糖醛酸转移酶的药物合用时, 因丙戊酸钠清除增加, 故丙戊酸钠需增量 5 ~ 10mg/kg/d^[1]。

最后, 吸烟和帕罗西汀不改变丙戊酸钠血浓度。

三、卡马西平降低其他药物血浓度

卡马西平诱导 1A2^[3]、3A4 (重度)^[3]、2C19 和 2C9 酶, 还可能诱导尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶, 理论上可降低经这些酶代谢的药物。

1. 抗精神病药

吩噻嗪类药物 (甲硫哒嗪、奋乃静、氟奋乃静和三氟哒嗪)、硫杂蒯类药物 (氯丙嗪和三氟丙嗪) 主要经 1A2 酶代谢^[3], 而氯丙嗪和氟丙嗪醇次主要经 1A2 酶代谢、卡马西平诱导 1A2 酶, 加速这些药物代谢, 理论上降低这些药物血浓度。几个病例报告显示, 在中断卡马西平 4 周期间, 典型抗精神病药血浓度增加 2 ~ 5 倍, 此间, 病人出现镇静或锥体外系不良反应, 甚至诱发恶性综合征^[1]。

(1) 氟丙嗪醇: 氟丙嗪醇次主要经 1A2 酶代谢, 主要经 3A4 酶代谢, 卡马西平诱导 1A2 酶和重度诱导 3A4 酶, 加速氟丙嗪醇代谢, 降低氟丙嗪醇血浓度。几个研究发现, 服卡马西平能降低氟丙嗪醇血浓度 50% ~ 60%, 恶化临床症状。

(2) 氯氮平: 氯氮平主要经 1A2 酶代谢, 次主要经 3A4 和 2C19 酶代谢, 次要经 2C9 酶代谢, 次主要经尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶代谢, 卡马西平诱导 1A2、3A4、2C19 和 2C9 酶和尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶, 加速氯氮平代谢, 降低氯氮平浓度 50%, 降低其疗效。由于卡马西平和氯氮平都降低白血球, 故这两种药物不要联用。

(3) 利培酮: 利培酮 20% 的经 3A4 酶代谢, 卡马西平重度诱导 3A4 酶, 加速利培酮代谢, 故利培酮联合卡马西平比单服利培酮降低利培酮血浓

度 50%, 降低 9-羟利培酮血浓度 80%, 降低活性部分 65%。1 例服利培酮的慢性精神分裂症病人添加卡马西平, 降低利培酮和 9-羟利培酮血浓度, 短期恶化精神病症状。

(4) 奥氮平: 奥氮平主要经 1A2 酶代谢, 次主要经 2C19 和 2C9 酶代谢, 次要经 3A4 酶代谢, 主要经尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶代谢, 按机制卡马西平可加速奥氮平代谢, 理论上降低奥氮平血浓度。两项服奥氮平的精神疾病病人研究表明, 奥氮平同服卡马西平比起单服奥氮平的病人, 奥氮平血浓度下降 30% ~ 50%。此时需增加奥氮平剂量才能达治疗浓度, 故不赞成卡马西平与奥氮平联用。

(5) 齐拉西酮: 齐拉西酮 1/3 的经 3A4 酶代谢, 卡马西平亦可理论上降低齐拉西酮血浓度。给健康志愿者服卡马西平, 平均降低齐拉西酮峰浓度 27%, 这无临床意义, 因为齐拉西酮的治疗指数宽。

(6) 阿立哌唑: 阿立哌唑主要经 3A4 酶代谢。Spigset 等 (2007) 研究了 81 例病人, 结果发现, 卡马西平降低校正剂量的阿立哌唑血浓度达 88%^[1]。

2. 抗抑郁药

(1) 三环抗抑郁药: 三环抗抑郁药经 1A2、3A4、2C19 和 2C9 酶代谢, 与卡马西平合用时加速去甲替林、丙咪嗪、氯丙咪嗪和去甲氯丙咪嗪代谢, 降低其血药浓度。

(2) 米氮平: 米氮平经 1A2 和 3A4 酶代谢, 给健康受试者服卡马西平, 确实显著降低米氮平血浓度。

3. 心境稳定剂

(1) 丙戊酸钠: 丙戊酸钠次要 (< 10%) 经 3A4 酶代谢, 卡马西平理论上对丙戊酸钠无明显影响。但实际上, 同服卡马西平能降低丙戊酸钠功效, 此时需监测丙戊酸钠血浓度^[1]。

(2) 拉莫三嗪: 拉莫三嗪经 3A4 酶代谢, 主要 (63%) 经尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶代谢; 卡马西平通过诱导以上两途径, 加速拉莫三嗪代谢, 理论上降低拉莫三嗪血浓度。成年健康志愿者服卡马西平, 拉莫三嗪血浓度降至 1/2, 半衰期由 24 小时缩至 15 小时。

(3) 托吡酯: 托吡酯经 3A4 酶代谢^[1], 同服卡马西平能增加托吡酯清除, 缩短其半衰期^[3]。

(4) 奥卡西平: 奥卡西平 - 10 - 羟基衍生物经尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶代谢, 卡马西平诱导尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶, 加速奥卡西平 - 10 - 羟基衍生物代谢, 故该药与卡马西平联合可显著降低奥卡西平 - 10 - 羟基衍生物血浓度。

4. 苯二氮䓬类药物

(1) 地西泮: 地西泮主要经 3A4 酶代谢^[9], 次要经 2C19 代谢^[10]。实际上, 服卡马西平的病人地西泮的清除率比对照组为高。

(2) 阿普唑仑: 阿普唑仑代谢途径与地西泮相似^[11]。卡马西平重度诱导 3A4 酶, 也诱导 2C19 酶, 加速阿普唑仑代谢, 理论上降低阿普唑仑血浓度。实际上, 卡马西平的确降低阿普唑仑血浓度, 恶化临床症状^[12]。

(3) 氯硝西泮: 氯硝西泮经 3A4 酶代谢, 卡马西平可加速氯硝西泮代谢, 降低其血药浓度。

5. 口服避孕药

口服避孕药中的雌激素和孕激素均经 3A4 酶代谢, 故卡马西平可加速雌激素和孕激素代谢, 降低口服避孕药功效, 导致意外妊娠, 此时应改用不经肝代谢的激素性避孕药 (如避孕肤贴), 或用屏障法和子宫内避孕装置^[13]。

四、其他药物增加卡马西平血浓度

卡马西平经 1A2、3A4 (主要) 酶和尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶代谢。凡是抑制这些酶的药物或物质都可能增加卡马西平血浓度。

(1) 丙戊酸钠增加卡马西平血浓度: 卡马西平经尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶代谢, 丙戊酸钠抑制尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶^[14], 从而抑制卡马西平代谢。卡马西平经 3A4 酶氧化成卡马西平 - 10, 11 - 环氧化物, 后者经环氧化物水解酶水解, 丙戊酸钠抑制该水解酶, 从而升高卡马西平活性代谢物卡马西平 - 10, 11 - 环氧化物浓度, 可引起中毒反应^[15], 表现共济失调、眼球震颤、复视、头痛、呕吐、癫痫发作和昏迷, 此时应测定卡马西平血浓度, 但无法常规测定卡马西平环氧化物浓度, 后者对功效和毒性也起作用^[16]。

(2) 氟西汀提高卡马西平血浓度? 卡马西平经 1A2 和 3A4 酶代谢, 同时又诱导 1A2 酶和重度诱导 3A4 酶; 氟西汀轻度抑制 1A2 酶, 氟西汀和去甲氟西汀轻 ~ 中度抑制 3A4 酶, 理论上可能稍稍升高卡马西平血浓度, 但临床结果自相矛盾。一些病例报告, 服氟西汀增加卡马西平血浓度, 可能

与中毒效应相关联。另 8 例癫痫病人服氟西汀 20mg/d 3 周时, 并不改变卡马西平血浓度, 机制可能是: 卡马西平对 1A2 和 3A4 酶的自身诱导效应有时抵消氟西汀对 1A2 和 3A4 酶的轻度抑制效应、只有当氟西汀剂量较高时, 其抑制 1A2 和 3A4 酶效应才不为卡马西平所抵消^[17]。

(3) 吸烟不影响卡马西平血浓度: 卡马西平经 1A2 酶代谢, 吸烟诱导 1A2 酶, 从而加速卡马西平代谢, 理论上降低卡马西平血浓度, 但实际上吸烟很少能降低卡马西平血药浓度。恐怕是因为卡马西平本身已最大化诱导 1A2 酶, 吸烟不能再进一步诱导 1A2 酶之故^[18]。

参 考 文 献

1. Fleming J, Chetty M. Psychotropic drug interactions with valproate. Clin Neuropharmacol, 2005; 28: 96 - 101.
2. Christensen M, Tybring G, Mihara K, et al. Low daily 10 - mg and 20 - mg doses of fluvoxamine inhibit the metabolism of both caffeine (cytochrome P4501A2) and omeprazole (cytochrome P4502C19) . Clin Pharmacol Ther. 2002; 71 (3) : 141 - 152.
3. Monaco F, Cicolin A. Interactions between anticonvulsant and psychiatric drugs. Epilepsia, 1999; 40 [Suppl, 10]: 71 - 76.
4. Spina E, Scaodo MG, D'Arrigo C. Metabolic drug interaction with new psychotropic agent. Fundamental & Clinical Pharmacology, 2003; 17: 517 - 538.
5. Sabers A. Pharmacokinetic interactions between contraceptives and antiepileptic drugs. Seizure. 2008 ; 17 (2) : 141 - 144.
6. Ereshefsky L. Drug - drug interactions involving antidepressants : focus on venlafaxine. Journal of Clinical Psychopharmacology, 1996; 16 [Suppl, 2]: 37 - 50.
7. Spigset O. Effects of comedication on the serum levels of aripiprazole: evidence from a routine therapeutic drug monitoring service. Pharmacopsychiatry, 2007; 40 (3) : 107 - 110.
8. Arold G, Donath F, Maurer A, et al. No relevant interaction with alprazolam, caffeine, tolbutamide, and digoxin by treatment with a low - hyperforin St John's wort extract. Planta Med. 2005 ; 71 (4) : 331 - 337.
9. Joffe H. Reproductive biology and psychotropic treatments in premenopausal women with bipolar disorder. J Clin Psychiatry, 2007; 68 [Suppl, 9]: 10 - 15.
10. Pratoomsri W, Yatham LN, Bond DJ, et al. Oxcarbazepine

- in the treatment of bipolar disorder: a review. Can J Psychiatry, 2006; 51(8) : 540 - 545.
11. Chen C, Chen CY, Lin KM. Ethnopsychopharmacology . Int Rev Psychiatry, 2008; 20(5) : 452 - 459.
- (收稿日期: 2010 年 4 月 26 日)

丙戊酸盐在抑郁发作中的应用

任志斌 金卫东 童振华

【摘要】 本文从丙戊酸盐对心境稳定的作用出发, 综述分析了丙戊酸盐治疗抑郁发作的效果, 在改善抑郁症状的同时, 特别可以改善焦虑、激惹以及冲动。与其他心境稳定剂相比有一定优势, 而且其还可以预防抑郁、躁狂的发作, 对快速循环也有良好治疗和预防作用。特别是为可能用于抑郁症的治疗或辅助治疗提供依据。

【关键词】 丙戊酸盐; 抑郁发作; 临床疗效; 预防效应

【中图分类号】 R749. 053 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1673 - 2952 (2011) 04 - 0270 - 03

心境稳定剂是指对躁狂或抑郁发作具有治疗和预防复发的作用, 且不会引起躁狂或抑郁转相, 或导致发作变频的药物。丙戊酸盐主要用于治疗双相情感障碍的躁狂发作, 特别是快速循环发作及混合发作效果较好, 对双相障碍有预防复发的作用。目前研究主要是双相障碍, 而单相抑郁症中的应用研究较少。我们将从治疗双相障碍延伸到对单相抑郁的治疗或辅助治疗。

一、急性期治疗的相关问题

1. 丙戊酸对抑郁症状的疗效

(1) 丙戊酸盐自身前后对照 Winsberg 在对双相 II 型抑郁病人的研究中发现 11 例病人经过丙戊酸盐治疗, 平均治疗剂量 886 ± 234 毫克/天, 血药浓度 71.2 ± 19.7 微克/毫升, 12 周后病人的汉密尔顿抑郁量表平均分从 20.6 下降到 6.6 ($t = 5.5$, $df = 10$, $P < 0.0003$), 存在统计学意义, 提示丙戊酸盐能明显改善抑郁症状^[1]。Pasuini 等对单相抑郁病人也进行了类似的研究, 在原来 SSRI 治疗的基础上联合丙戊酸盐, 结果抑郁症状、焦虑症状、敌意和激惹现象都得到显著改善, 比原来单一使用 SSRI 进步 82%, 这说明丙戊酸盐可以改善抑郁症状^[2]。

(2) 丙戊酸盐与安慰剂的比较 在 Ghaemi 等一项双盲随机的试验研究中, 入组者是 18 位双相抑郁急性发作的门诊病人, 随机分为两组, 其中 9 例病人服用丙戊酸盐, 另 9 例服用安慰剂, 用蒙哥马利抑郁量表 (MADRS) 评价并观察 6 周, 结果丙戊酸盐治疗组在 MADRS 减分与安慰剂组有显著性差异 ($P = 0.0078$), 用绝对的改变来看, 丙戊酸盐治疗组抑郁症状分改善了 13.6, 而安慰剂组仅改善了 1.4, 差异明显 ($P = 0.003$), 其改善的症状除抑郁的核心症状之外, 还有焦虑和失眠。更有意义的是, 丙戊酸盐治疗组的这些症状的改善与用躁狂评定量表的改善呈显著相关性 ($r = 0.29$, $df = 51$, $P = 0.03$), 而在安慰剂组则不存在这种相关关系 ($r = -0.15$, $df = 35$, $P = 0.36$), 这些结果说明不仅丙戊酸盐可以治疗抑郁症状, 更可能是对混合发作有效果^[3]。这与另一项研究的结果相同, 这是一项对双相 I 型抑郁的研究, 入组者是 25 例双相 I 型抑郁急性发作的门诊病人, 12 例病人服用安慰剂, 13 例服用丙戊酸盐, 用 HAMD 评价并观察 8 周, 丙戊酸盐治疗组汉密尔顿抑郁量表减分平均值为 -43.51, 而安慰剂组减分平均值为 -27.00 ($S. E. = 3.16$), 两者之间存在统计学差

(作者工作单位) 浙江省立同德医院, 浙江省精神卫生中心 (杭州, 310012) 。

(第一作者介绍) 任志斌 (1978 -), 男, 山西人, 学士, 研究方向: 心境障碍。

(通信作者) 金卫东 (Email: wdjin@163.com) 。